

Программа ранней диагностики колоректального рака в РК

Нургазиев К.Ш., Ижсанов Е.Б., Кузикеев М.У., Лаишул С.В. Джуманов А.И.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии (КазНИИОнР),
г. Алматы, Республика Казахстан.

Введение

По данным эпидемиологических исследований в последние десятилетия в большинстве цивилизованных стран мира отмечается неуклонное увеличение показателей заболеваемости населения колоректальным раком (КРР). КРР является широко распространенной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500.000. Сегодня в большинстве стран Европы, Азии, США КРР занимает первое место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, является второй по частоте злокачественной опухолью у мужчин (после бронхолегочного рака) и третьей – у женщин (после бронхолегочного рака и рака молочных желез). По прогнозам экспертов, абсолютное число случаев КРР в мире в следующие два десятилетия увеличится в результате роста населения в целом и его старения как в развитых, так и в развивающихся странах. Показатели заболеваемости КРР сегодня достигают 85-90 на 100 тыс. населения, возрастая с 24,9 на 100 тыс. населения в возрастной группе до 50 лет – до 249,7 на 100 тыс. населения среди пациентов старше 60 лет.

В структуре смертности от злокачественных новообразований лиц обоего пола КРР занимает второе место.

Степень риска возникновения КРР меняется от страны к стране и даже в пределах одной страны. Она также разнится между отдельными лицами в зависимости от особенностей диеты, стиля жизни и наследственных факторов.

Согласно базе данных Globocan Международного Агентства по изучению рака (IARC) заболеваемость КРР в 2008 году в мире составила 663904, а смертность – 320397 случаев среди мужчин и соответственно 571204 и 288654 случаев среди женщин. В 2008 году КРР составил 9,8% всех случаев рака в мире у лиц обоего пола. Чаще всего он регистрируется в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и в различных частях Европы. Вследствие этого КРР рассматривается как болезнь урбанизированного образа жизни. В Республике Казахстан в 2010 году выявлено 2568 больных КРР, умерло 1555. КРР занимает 5-ое место в структуре онкозаболеваемости и 3 место в структуре онкосмертности.

Чаще всего КРР возникает из аденом толстой кишки, и в отдельных случаях у пациентов с генетически детерминированными синдромами полипоза или воспалительными заболеваниями кишки. Имеются сообщения, полученные при проведении колоноскопии в рамках скрининга, о том, что распространенность аденоматозных полипов составляет 18-36%.

Благодаря высокой частоте обнаружения предопухолевых состояний и хорошей выживаемости в случае ранней диагностики, КРР рассматривают как идеальную модель для скрининга. Только 60% больных с распространенными опухолями выживают в течение 5 лет после постановки диагноза.

Учитывая ситуацию по КРР в РК, а именно: низкую 5-летнюю выживаемость (44,7%), позднюю диагностику (57,8% выявляется в 3-4 стадиях) в Государственную про-

Қазіргі таңда әлем елдерінің көпшілігінде алдыңғы қатарлы медицина ұйымдарының ұсыныстарына сәйкес колоректалды обыр ауруын ерте анықтау скринингтік бағдарламалар енгізіліп, жүзеге асырылып келеді. Ондай бағдарламаның басты мақсаты ауруды ерте анықтауды есейтіп, емдеу нәтижелерін жақсарту арқылы өлім ахуалын төмендетуге бағытталған. 2011 жылдан бастап КРҚІ ерте анықтау бойынша скринингтік бағдарламасы енгізілген ТМД елдері арасында Қазақстан тұңғыш мемлекет.

Аталған мақалада колоректелді қатерлі ісігін ерте анықтау бағдарламасының негіздемесі, оның мазмұны мен күтілетін нәтижелері ұсынылған.

В последние годы в большинстве развитых стран мира разрабатываются и проводятся различные скрининг-программы по ранней диагностике колоректального рака (КРР), согласно рекомендациям ведущих медицинских организаций. Целью таких программ в первую очередь является снижение смертности через повышение ранней диагностики и улучшения результатов лечения. Казахстан – первая страна в СНГ, где с 2011 года введена скрининговая программа по ранней диагностике КРР.

В данной статье представлено обоснование скрининга колоректального рака, его характеристика, а также ожидаемые результаты.

Last years in the majority of the developed countries are implemented various screening programs on early colorectal cancer detection (CRC) according to recommendations of the leading medical organizations. The purpose of these programs is a decreasing of mortality rate through increasing of early detection and improvement of treatment results. Kazakhstan is the first country among CIS which implemented the CRC screening program since 2011.

The justification of the esophagus and stomach cancer early detection program, its characteristic and expected results is presented at the submitted article.

грамму развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, включен скрининг КРР.

Целью

исследования является определение основных характеристик программы по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и рака толстой и прямой кишки, когда лечение наиболее эффективно и малозатратно, способствует в комплексе с другими методами снижению смертности больных.

Материалы исследования

Международные рекомендации, исследования специалистов в области профилактики, ранней диагностики, организации оказания онкологической помощи.

Методы

- исторический, контент-анализ.

Результаты исследований

Даны следующие характеристики скрининга колоректального рака в Казахстане.

Вид скрининга: популяционный скрининг

Целевая группа: мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет.

Методы скрининга: иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь – iFOBT-тест + тотальная колоноскопия.

Уровень проведения скрининга: начиная с медицинского пункта в сельской местности и в поликлинике на уровне города.

Интервал: 1 раз в 2 года

Срок действия: постоянно

Определен алгоритм действий медицинских работников первичной медико-санитарной помощи.

Иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь – iFOBT-тест (гемокульт-тест) проводится всем мужчинам и женщинам целевой группы. При положительном тесте пациент направляется на тотальную колоноскопию. Наличие патологического образования прямой кишки и нижних отделов сигмовидной кишки, выявленного в процессе ректосигмоскопии, не исключает наличия опухоли в вышестоящих отделах толстого кишечника. Колоноскопия проводится в клинично-диагностическом центре или онкологическом диспансере с взятием биопсии.

Исследование материала биопсии толстой кишки, полученного в результате эндоскопического исследования проводится патоморфологами по месту взятия в соответствии с общепринятыми международными стандартами и классификацией ВОЗ (Лион, 2000 г.).

Безусловно, важная роль в активном выявлении ранних форм КРР остается за профилактическими осмотрами, что, как правило, комбинируется с эндоскопическими методами. Однако стоимость таких скрининговых мероприятий чрезвычайно высока, кроме того, инвазивный характер исследований не позволяет использовать их повсеместно. Это заставляет искать простые лабораторные (неинвазивные) методы скринингового типа.

Традиционно к таким методам относится бензидиновая проба на скрытую кровь в кале (FOBT, гемокульт-тест). Это биохимический метод, основанный на оценке псевдопероксидазной активности гемоглобина.

Предложенный в последние годы метод иммуноферментного определения гемоглобина человека в кале (iFOBT), по данным ряда авторов, отличается высокой диагностической значимостью: чувствительность составляет 60-77,7% при специфичности 95%. Высокая специфичность теста связана с тем, что iFOBT не выявляет кровь из опухолей, находящихся в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, не реагирует с пероксидазой растительного происхождения и гемоглобином из пищи животного происхождения (как в случае ложно-положительного результата при FOBT). Он достаточно прост в выполнении, не требует от пациента соблюдения особой диеты, является неинвазивным и экономически выгодным по сравнению с эндоскопическими методами. Это позволяет рассматривать iFOBT как копрологический тест скринингового типа. В та-

блице представлен сравнительный анализ теста кала на скрытую кровь на основе гваяковой смолы и iFOBT.

Таблица. Сравнение тестов кала на скрытую кровь для скрининга на КРР

Критерий ВОЗ	Гваяковый	Иммуно-химический
Не требует посещения врача	Да	Да
Хорошо организуемый	Да	Да
Быстрый и удобный забор материала	Да	Да
Специфичен для кишечных кровотечений	Нет	Да
Применим к популяционному скринингу	Да	Да
Метод, доступный контролю качества и объективному анализу	Да	Да

В дополнении, следует отметить следующие преимущества iFOBT:

- специфичен для человеческого гемоглобина и не зависит от диеты и приема лекарств;
- отмечены высокие показатели участия и восприятия населением по сравнению с обычной сдачей кала на исследование;
- достаточно одного или двух образцов кала, а не трех, как при гваяковой пробе;
- имеет сопоставимые или превосходящие характеристики (чувствительность, специфичность);
- имеются автоматизированные платформы для проверки тестов, которые более доступны контролю качества, пропускная способность гораздо выше и конечный результат основывается на концентрации гемоглобина.
- возможность централизации всего колоректального скрининга в одной центральной лаборатории.

Несмотря на большой выбор имеющихся и разрабатываемых неинвазивных скрининговых методов, до настоящего времени «золотым стандартом» ранней диагностики КРР является колоноскопия с тотальным осмотром толстой кишки и терминального отрезка подвздошной кишки. Это исследование позволяет получить информацию о локализации новообразования, установить протяженность поражения, определить форму роста опухоли, оценить ее подвижность, а иногда – судить о взаимосвязи с другими органами.

Результаты

Опыт проведения скрининговых программ в европейских странах позволяет ожидать выявления ранних форм КРР и снижения смертности на 25-30%. Однако следует отметить, что достоверного изменения структуры заболеваемости и смертности следует ожидать не ранее, чем через 5-10 лет планомерного осуществления программы.

Литература

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Ж. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан, статистические материалы 2001-2010 гг.
2. Практическое руководство Всемирного гастроэнтерологического общества (ВГО) и Международного союза по профилактике рака пищеварительной системы: Скрининг колоректального рака (WGO Practice Guidelines 2008).
3. World Health Organisation & World Organisation of Digestive Endoscopy. Am J Gastroenterology 2002; 97:2499-2507.
4. Recommendations for a colorectal cancer screening programme in Ireland. 2008.